

TEMA 2.16 • GINECOLOGÍA

Infertilidad

PERFIL EUNACOM 2.01.1.081
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Infertilidad

Definición

Imposibilidad de lograr embarazo tras **≥ 1 año de relaciones sin anticoncepción**.

- Es un **diagnóstico de pareja** (independiente de hijos previos con otras personas)
- **Primaria:** La pareja nunca ha logrado embarazo
- **Secundaria:** Han logrado al menos un embarazo previo (aunque haya terminado en aborto)

Causas y Frecuencia

TABLA 2.16.1: CAUSA VS FRECUENCIA		
CAUSA	FRECUENCIA	DETALLE
Masculina	~40%	Azoospermia, oligospermia, astenospermia, teratospermia
Anovulación	~25%	SOP, obesidad
Factor tubo-peritoneal	~20%	Adherencias por PIP previo
Endometriosis	~10%	Adherencias peritoneales
Otras	~5%	Insuficiencia lútea, patología cervical (moco), malformaciones uterinas

Estudio de la Infertilidad (en orden)

Primera Línea

TABLA 2.16.2: EXAMEN VS EVALÚA	
EXAMEN	EVALÚA
Espermograma	Factor masculino (morfología, movilidad, concentración)
Seguimiento folicular (ETV seriada)	Anovulación; confirma ovulación y ciclo ovulatorio
Test postcoital	Factor cervical: muestra de semen en cuello post-coito → ve si espermios están vivos y móviles

Segunda Línea

TABLA 2.16.3: EXAMEN VS EVALÚA	
EXAMEN	EVALÚA
Histerosalpingografía (HSG)	Factor tubo-peritoneal: inyecta contraste → ve trompas (obstrucción, hidrosálpinx)

Última Línea

TABLA 2.16.4: EXAMEN VS EVALÚA	
EXAMEN	EVALÚA
Laparoscopia	Endometriosis (gold standard diagnóstico-terapéutico)

Tratamiento según Causa

TABLA 2.16.5: CAUSA VS TRATAMIENTO	
CAUSA	TRATAMIENTO
Masculina (oligospermia)	Inseminación intrauterina o FIV
Azoospermia completa	Donante de espermios
Anovulación	Inductores de ovulación: citrato de clomifeno (induce pico de LH) o hCG (simula pico de LH)
Falla ovárica	Donante de óvulos
Factor tubo-peritoneal	Cirugía (remoción de adherencias por laparoscopia)
Endometriosis	Cirugía (laparoscopia) → diagnóstica y terapéutica simultáneamente

Complicaciones de las Técnicas de Fertilidad

Embarazo Múltiple

- Más frecuente - Por inducción de múltiples folículos o implantación de varios embriones en FIV

Síndrome de Hiperestimulación Ovárica (SHO)

- **Causa:** Inducción de ovulación → sobreestimulación de ovarios - **Clínica:** - Dolor abdominal (ovarios muy aumentados) - Ascitis - **Hemoconcentración** (↑ hematocrito) - Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) - Complicaciones graves: edema pulmonar agudo, hepatitis, muerte - **Tratamiento:** Soporte de síntomas y complicaciones; casos graves: agonistas dopaminérgicos (cabergolina)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Pareja consulta por infertilidad primaria de 14 meses. Mujer de 32 años con ciclos regulares de 28 días, progesterona fase lútea 12 ng/mL. Espermograma del hombre: volumen 2.5 mL, concentración 18 millones/mL, motilidad progresiva 35%, morfología normal 5%. Histerosalpingografía de la mujer: normal. ¿Cuál es la causa más probable de infertilidad y la conducta inicial?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Infertilidad. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Definición
- Causas y Frecuencia
- Estudio de la Infertilidad (en orden)
- Primera Línea
- Segunda Línea
- Última Línea
- Tratamiento según Causa

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INFERTILIDAD)

PREGUNTA 1

Pareja consulta por infertilidad primaria de 14 meses. Mujer de 32 años con ciclos regulares de 28 días, progesterona fase lútea 12 ng/mL. Espermograma del hombre: volumen 2.5 mL, concentración 18 millones/mL, motilidad progresiva 35%, morfología normal 5%. Histerosalpingografía de la mujer: normal. ¿Cuál es la causa más probable de infertilidad y la conducta inicial?

- A) Factor uterino — histeroscopia diagnóstica
- B) Factor masculino leve (oligoastenoteratozoospermia leve) — inseminación intrauterina (IIU)
- C) Factor ovulatorio — estimulación ovárica con clomifeno
- D) Infertilidad inexplicada — fertilización in vitro (FIV) directa
- E) Factor tubárico bilateral — FIV

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Infertilidad?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Infertilidad. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: INFERTILIDAD